Клинические рекомендации

Множественные переломы мозгового и лицевого черепа

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**S02.0** — Перелом свода черепа **S02.1** — Перелом основания черепа **S02.4** — Перелом скуловой кости и верхней челюсти **S02.6** — Перелом нижней челюсти **S02.7** — Множественные переломы черепа и лицевых костей **S02.8** — Переломы других лицевых костей и костей черепа **S02.9** — Перелом неуточненной части костей черепа и лицевых костей **S07** — Размозжение головы
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 24.12.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России; Ассоциация травматологов-ортопедов России; ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»; Всероссийское Общество по детской нейрохирургии
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/871_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Этиология и эпидемиология 3

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика 5

3.1 Догоспитальный этап 5

3.2 Жалобы и анамнез 6

3.3 Осмотр, пальпация и перкуссия 6

3.4 Анализы крови и мочи 6

3.5 Компьютерная томография 6

3.6 Исследование ликвора и отделяемого из носа 7

3.7 Консультации специалистов 7

4. Лечение 7

4.1 Консервативное лечение 7

4.2 Сроки репозиции и иммобилизации отломков 7

4.3 Ортопедическое лечение 8

4.4 Хирургическое лечение 8
4.5 Антибактериальная профилактика 9
4.6 Антибактериальная терапия 10
4.7 Обезболивание и иное лечение 10
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 11
5.1 Показания к госпитализации 11
5.2 Медицинская реабилитация 11
5.3 Диспансерное наблюдение 11
6. Источник и актуальность 11
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 12

1. Основные положения

- Черепно-лицевая травма — повреждение мозгового отдела черепа и (или) головного мозга в сочетании с травмой лицевого отдела черепа. При подозрении на перелом черепа показана экстренная госпитализация в специализированный стационар.
- Первоочередные задачи на месте: восстановление дыхания (асфиксия при переломах челюстей), остановка кровотечения, транспортная иммобилизация, экстренная доставка в стационар.
- Базальная ликворея — признак перелома основания черепа. Её отличают от отделяемого из носа по глюкозе и специфическим маркерам (beta-2 transferrin); фистулу закрывают хирургически при неэффективности консервативной терапии в течение **5–7 дней**, в том числе эндоназально эндоскопически.
- При кровотечении из носа с угрозой аспирации выполняют интубацию или вводят S-образный воздуховод и проводят переднюю и заднюю тампонаду носа; при профузных рецидивирующих носовых кровотечениях показаны эндоваскулярная эмболизация или эндоназальная перевязка (коагуляция) крылонёбной артерии.
- В стационаре выполняют МСКТ головного мозга и лицевого отдела черепа и назначают консультации нейрохирурга, челюстно-лицевого хирурга, офтальмолога и оториноларинголога.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Множественная травма — травма, в результате которой возникло два и более повреждения мягких тканей и (или) костей в пределах одной анатомической области.

Черепно-лицевая (краниофациальная) травма — повреждения мозгового отдела черепа и (или) головного мозга в сочетании с травмой лицевого отдела черепа.

Перелом костей основания черепа — повреждение основания черепа с нарушением его анатомической целостности и функциональными расстройствами; к ним относятся переломы глазничной поверхности лобной кости, пирамиды височной кости, решётчатой пластинки, клиновидной кости, затылочной кости с переходом на большое затылочное отверстие.

Вдавленный перелом черепа — перелом, при котором фрагменты кости смещаются более чем на толщину прилежащей кости.

Повреждения средней зоны лица чаще всего множественные и сочетанные. При одновременном повреждении костей носа, решётчатой кости и других костей средней зоны их объединяют понятием травмы средней зоны лица. Сочетанные повреждения вызывают «синдром взаимного отягощения».

2.2 Этиология и эпидемиология

Переломы лицевого черепа составляют 3–4% травм с повреждением костей: нижняя челюсть — 65,1%, скуловая кость и дуга — 12,8%, кости носа — 3,8%, верхняя челюсть — 2,0%. Причинами являются ДТП, падения с высоты, реже производственная и спортивная травма. Переломы челюстей в пределах зубного ряда считаются заведомо открытыми.

Переломы основания черепа составляют 4% тяжёлых ЧМТ; у 32–59% линия перелома переходит со свода на основание. Летальность при сочетанной черепно-лицевой травме у детей — 7,1–22%.

2.3 Классификация

Локализация переломов по зонам лица

1. **верхняя зона лица**: передняя стенка лобной пазухи, крыша глазницы
2. **средняя зона лица**: назоэтмоидальный комплекс, кости носа, скулоорбитальный комплекс, верхняя челюсть по верхнему, среднему и нижнему уровню, альвеолярный отросток
3. **нижняя зона лица**: нижняя челюсть

Переломы костей носа рассматриваются в отдельных КР (оториноларингология), переломы орбиты — в офтальмологических; здесь они упоминаются только в составе множественных переломов.

Классификация черепно-лицевой травмы

1. **субкраниальные**: назоорбитальные и назомаксиллярные, центральные (Ле Фор I, II, Вассмунд I, II), центролатеральные (Ле Фор III, Вассмунд IV), латеральные (скуловая кость, дуга, скулоорбитальный комплекс)
2. **краниофациальные**: верхняя и средняя зоны лица с передней черепной ямкой; панфациальные: все зоны лица и основание черепа
3. **фронтофациальные**: передняя черепная ямка и верхняя зона: стенки лобной пазухи, верхний край и стенка орбиты, решётчатая пластинка, задние решётчатые ячейки, верхняя и латеральная стенки клиновидной пазухи

Из-за плотного прилегания твёрдой мозговой оболочки и сообщения с пазухами большинство переломов основания черепа рассматриваются как открытые проникающие; они возможны даже при незначительной травме.

2.4 Клиническая картина

Признаки перелома основания черепа

1. гипосмия или аносмия;
2. базальная ликворея;
3. глазодвигательные нарушения (III, IV, VI нервы), повреждение зрительного нерва;
4. одно- и двусторонние нарушения слуха, спонтанный нистагм;
5. при поперечном переломе пирамиды: выпадение слуха и вестибулярной функции, повреждение лицевого нерва.

Наружные признаки, указывающие на характер перелома

1. периорбитальная гематома (симптом «очков») **через 12–48 часов** указывает на перелом передней черепной ямки;
2. гематома в области сосцевидного отростка (симптом Бэттла), лагофтальм, асимметрия лица указывают на перелом пирамиды височной кости и парез лицевого нерва;
3. гемотимпанум или разрыв барабанной перепонки могут свидетельствовать о переломе основания черепа;
4. рино- или отоликворея указывает на перелом передней или средней черепной ямки;
5. эмфизема лица указывает на перелом лицевых костей, возможно дна передней черепной ямки;
6. экзофтальм с отёком конъюнктивы указывает на каротидно-кавернозное соустье или ретробульбарную гематому;
7. кровотечение из носа или ушей, нарушение слуха, нистагм, рвота.

Раннюю ликворею трудно распознать при сочетании с кровотечением; помогает проба со светлым ободком вокруг кровянистого пятна на марлевой салфетке.

Симптомы при повреждениях зон лица

1. **верхняя зона**: асимметрия, параорбитальные гематомы, симптом «лица панды» в первые часы, истинный симптом «очков» через сутки, затруднение носового дыхания, диплопия, эмфизема, кровотечение и (или) ликворея из носа
2. **средняя зона**: уплощение средней зоны, деформация носа, симптом «очков», затруднение носового дыхания, кровотечение и (или) ликворея из носа, подвижность фрагментов, нарушение прикуса и открывания рта
3. **нижняя зона**: симптом «ступеньки», патологическая подвижность фрагментов, симптом непрямой нагрузки, нарушение движений челюсти и прикуса

Симптомы множественных переломов лица малозаметны из-за отёка и кровоизлияний; даже при кровотечении и ликворее их не всегда вовремя диагностируют у тяжелопострадавших с явными повреждениями других областей.

---

3. Диагностика

3.1 Догоспитальный этап

Признаки перелома лицевых костей на догоспитальном этапе

1. деформация лица за счёт западения или отёка;
2. нарушение прикуса;
3. нарушение чувствительности в зоне подглазничного и (или) подбородочного нерва;
4. ограничение подвижности нижней челюсти;
5. патологическая подвижность и крепитация отломков, положительная проба непрямой нагрузки.

Восстановление дыхания

1. осмотр и санация полости рта: сгустки, осколки зубов, инородные тела;
2. при двустороннем переломе нижней челюсти: фиксация языка;
3. боковое стабильное положение;
4. при отёке, затрудняющем дыхание: S-образный воздуховод.

Асфиксия при челюстно-лицевых ранениях: дислокационная (40%), обтурационная (29%), стенотическая (23%), клапанная (5%), аспирационная (3%).

Кровотечение останавливают зажимом, тугой тампонадой раны, жгутом на шею через поднятую противоположную руку или пальцевым прижатием. Для транспортной иммобилизации применяют стандартную или теменно-подбородочную пращевидную повязку.

Очерёдность медицинской эвакуации

1. **первая очередь**: тяжёлое и крайне тяжёлое состояние: нарушение сознания, очаговая неврологическая симптоматика, продолжающееся кровотечение, ликворея, нарушение дыхания, тахикардия 100 и более, АД 100 мм рт. ст. и ниже, гемоглобин менее 100 г/л
2. **вторая очередь**: удовлетворительное или среднетяжёлое состояние с множественными повреждениями, подозрением на сотрясение мозга, возрастом **старше 60 лет**, сопутствующими заболеваниями
3. **третья очередь**: изолированная травма челюстно-лицевой области без неврологической симптоматики и кровотечения

3.2 Жалобы и анамнез

Анамнез собирают у пострадавшего, сопровождающих и из листа скорой помощи.

Что уточнить

1. механизм травмы, травмирующий предмет, время и место;
2. нарушение сознания и амнезию, их длительность;
3. прививку от столбняка, аллергию, сопутствующие заболевания;
4. лечение до поступления и его результат.

3.3 Осмотр, пальпация и перкуссия

Всем пациентам показаны оценка общего состояния, осмотр, пальпация и перкуссия челюстно-лицевой области; при осмотре выявляют признаки перелома черепа, следы кровотечения, истечения ликвора или детрита из раны.

Что отметить при осмотре

1. деформацию и симметричность лица, отёк, гематомы, раны, эмфизему;
2. движения глазных яблок, межкантальное расстояние;
3. кровотечение или ликворею из носа, уплощение средней зоны лица;
4. зоны нарушения чувствительности;
5. открывание рта, прикус, болезненность при перкуссии зубов.

При кровотечении и переломах основания и лицевого отдела черепа с угрозой аспирации показаны срочная интубация трахеи или S-образный воздуховод; кровотечение останавливают механически, выполняя переднюю и заднюю тампонаду носа и ротоглотки.

Высокий риск осложнений: асфиксия, анемия, бронхолёгочные гнойные заболевания, синуситы, внутричерепные гнойные осложнения, травматический остеомиелит, посттравматическая деформация.

Тяжесть состояния оценивают нейрохирург, челюстно-лицевой хирург, анестезиолог-реаниматолог, при сочетанной травме — травматолог и хирург.

3.4 Анализы крови и мочи

Всем пациентам показаны лабораторные исследования для оценки тяжести (общий анализ крови и мочи и др.); при ЧМТ следует руководствоваться рекомендациями «Очаговая травма головного мозга» и «Черепно-мозговая травма у детей».

3.5 Компьютерная томография

В стационаре выполняют МСКТ; всем пациентам с подозрением на перелом черепа при поступлении проводят КТ головного мозга. При необходимости применяют конусно-лучевую КТ, особенно для средней зоны лица.

ЛОР-структуры при МСКТ

1. верхнечелюстные пазухи: положение, симметричность, гемосинус, повреждение стенок;
2. решётчатые ячейки, лобные и клиновидная пазухи;
3. кости носа, перегородка, носовые раковины, сошник.

Поиск ликворной фистулы

1. КТ с толщиной срезов 1–3 мм и коронарной реконструкцией: решётчатая пластинка, стенки решётчатых ячеек, верхняя стенка клиновидной пазухи, крыша барабанной полости;
2. аксиальные срезы: задняя стенка лобной пазухи, стенки клиновидной пазухи, ячейки сосцевидного отростка;
3. визуализация самой фистулы: КТ-цистернография.

По показаниям выполняют МРТ головного мозга и лицевого черепа (кровоизлияния, эмфизема в тканях глазницы); КТ-ангиографию проводят при вдавленном переломе над крупными венозными синусами.

При отсутствии КТ выполняют рентгенографию черепа как минимум в 2 проекциях.

3.6 Исследование ликвора и отделяемого из носа

Спинномозговую пункцию выполняют при подозрении на интракраниальные гнойные осложнения и отсутствии признаков дислокации.

При подозрении на базальную ликворею исследуют глюкозу в отделяемом из носа и уха. В ликворе глюкозы больше (2,3–4,0 ммоль/л), а белка меньше (0,10–0,22 г/л), чем в серозном отделяемом.

Специфические маркеры ликвора — beta-2 transferrin (есть только в ликворе) и beta-trace protein (в ликворе 18,4 мг/л, в крови 0,59 мг/л).

3.7 Консультации специалистов

Для исключения ЧМТ, повреждения ЛОР-органов и органа зрения показаны МСКТ и консультации специалистов:

1. нейрохирург (при его отсутствии — невролог);
2. челюстно-лицевой хирург;
3. офтальмолог;
4. оториноларинголог;
5. детский стоматолог.

При подозрении на повреждение внутренних органов — хирург, травматолог, реаниматолог.

---

4. Лечение

План лечения составляет челюстно-лицевой хирург совместно с нейрохирургом; офтальмолог, оториноларинголог, травматолог привлекаются по характеру травмы. Часто приоритетны нейрохирургические операции. Решающим фактором исхода является время от травмы до специализированного лечения.

4.1 Консервативное лечение

При отсутствии показаний к операции лечение проводится в соответствии с тяжестью ЧМТ. С консервативной терапии начинают в двух ситуациях.

Посттравматический парез лицевого нерва при переломе височной кости

1. глюкокортикоиды;
2. вазодилататоры;
3. физиотерапия.

Базальная ликворея

1. постельный режим в положении полусидя;
2. серия люмбальных пункций или наружный люмбальный дренаж;
3. дегидратационная терапия.

4.2 Сроки репозиции и иммобилизации отломков

Репозицию и фиксацию отломков целесообразно отложить до стабилизации: при тяжёлом состоянии — через **2–7 суток и более**, после противошоковых мероприятий. Первичную хирургическую обработку ран проводят как можно раньше; глухой шов — до **24–36 часов** после травмы.

Сроки иммобилизации по сочетанию ЧМТ и переломов лица

1. тяжёлая ЧМТ и тяжёлые переломы лица: временная иммобилизация после выведения из шока, лечебная: **на 2–5-е сутки**, остеосинтез **не ранее 7-х суток**;
2. тяжёлая ЧМТ и нетяжёлые переломы лица: лечебная иммобилизация **через 1–3 суток**;
3. нетяжёлая ЧМТ и тяжёлые переломы лица: иммобилизация и остеосинтез **в первые сутки**;
4. нетяжёлая ЧМТ и нетяжёлые переломы: **в первые часы**.

4.3 Ортопедическое лечение

У детей основным является ортопедический метод; иммобилизацию выполняют индивидуальными проволочными, ленточными или пластмассовыми назубными шинами.

При ЧМТ с позывами на рвоту, особенно у детей, назубные шины и межчелюстную тягу в первые **2–3 суток** лучше не накладывать из-за риска аспирации и асфиксии; возможна шина без межчелюстной фиксации.

Переломы нижней челюсти у детей со сформированным постоянным прикусом (**после 12–13 лет**): ортопедическая иммобилизация назубными проволочными (стандартными ленточными) шинами с межчелюстной эластичной тягой.

4.4 Хирургическое лечение

Показания к хирургическому лечению

1. невозможность репонировать смещённые фрагменты ортопедическими методами из-за значительного смещения или при многооскольчатых переломах;
2. недостаточное число устойчивых зубов для стабильной ортопедической фиксации фрагментов челюсти;
3. интерпозиция мягких тканей в щели перелома;
4. переломы скулоорбитального, скулоназоорбитального, скулоназоэтмоидального комплексов, стенок орбиты, стенок лобной пазухи;
5. проникающий вдавленный перелом (раневая ликворея, выделение детрита, пневмоцефалия);
6. активное кровотечение из раны, сильное загрязнение раны, раневая инфекция;
7. истечение ликвора через нос, не останавливающееся консервативными методами;
8. отсутствие эффекта консервативного лечения или отсроченный парез лицевого нерва;
9. отсроченное ухудшение зрения при повреждении зрительного нерва в канале;
10. сдавление мозга, «растущий перелом», косметически значимая деформация.

Противопоказания

1. декомпенсированная соматическая патология;
2. острая ЧМТ тяжёлой и крайне тяжёлой степени, реже средней;
3. травматический или геморрагический шок с нестабильной гемодинамикой.

Основным методом является остеосинтез пластинами и винтами для черепно-лицевой хирургии. Детям нерассасывающиеся пластины после консолидации обязательно удаляют.

Доступы к средней зоне: коронарный, трансконъюнктивальный, субцилиарный, транскутанный по нижнему краю глазницы, трансоральный, трансантральный (гайморотомия), по Лимбергу.

Операции при переломах черепа

1. удаление внутричерепных гематом, декомпрессивная трепанация;
2. закрытие базальной ликворной фистулы при неэффективности консервативной терапии **5–7 дней** — транскраниально или эндоназально эндоскопически;
3. декомпрессия лицевого нерва через среднюю черепную ямку или транслабиринтно;
4. декомпрессия зрительного нерва;
5. эндоваскулярные вмешательства при ложных аневризмах, соустьях и профузных рецидивирующих носовых кровотечениях; перевязка или коагуляция крылонёбной артерии эндоназальным доступом;
6. репозиция вдавленного перелома у детей элеватором.

При переломе черепа рекомендуется раннее хирургическое вмешательство; при вдавленном переломе давностью до суток без загрязнения раны — репозиция отломков или первичная пластика дефекта.

У младенцев и детей младшего возраста при вдавленных или растущих переломах для восстановления твёрдой мозговой оболочки и костей свода черепа используют только аутоткань: апоневроз, надкостницу, расщеплённую кость, рёбра.

4.5 Антибактериальная профилактика

Всем пациентам, которым планируется операция, показана периоперационная антибиотикопрофилактика: разовая терапевтическая доза за **30–60 минут** до разреза, как правило однократно; при продлении: отмена не позднее **24 часов** после операции.

Препараты в зависимости от доступа

1. наружный доступ без сообщения с полостью рта: цефазолин или цефуроксим;
2. внутриротовой доступ, сообщение с полостью рта, открытый перелом: цефазолин или цефуроксим + метронидазол либо амоксициллин + клавулановая кислота;
3. аллергия на бета-лактамы, риск MRSA — ванкомицин (за 120 минут до разреза).

Доза цефазолина у детей после 3 лет

1. масса тела до 80 кг: 1 г;
2. масса тела 80 кг и более: 2 г.

Если продолжительность операции превышает 2 периода полувыведения препарата, вводится дополнительная разовая доза.

4.6 Антибактериальная терапия

Показания

1. рана IV типа («инфицированная»): старая травма, предшествующая инфекция, гнойное отделяемое, нежизнеспособные ткани.

Ориентируются на терапевтические дозы по инструкции с учётом массы тела, возраста, функции почек и печени.

Амоксициллин + клавулановая кислота внутривенно

1. взрослые и подростки старше 12 лет: 1 г (по амоксициллину) 3 раза в сутки, максимальная суточная доза 6 г;
2. дети до 12 лет: 25 мг/кг в сутки;
3. длительность: до 14 дней.

Цефазолин

1. дети: 25 мг/кг/сут, в тяжёлых случаях до 100 мг/кг/сут;
2. дети до 1 месяца: противопоказан;
3. длительность: 7–10 дней.

Метронидазол внутривенно капельно

1. дети до 12 лет: 7,5 мг/кг на введение;
2. дети старше 12 лет: 500 мг на введение.

Цефуроксим

1. дети, включая грудных: 30–100 мг/кг/сут в 3–4 введения;
2. новорождённые и дети до 3 месяцев: 30 мг/кг/сут в 2–3 введения.

Ванкомицин только внутривенно

1. взрослые и дети старше 12 лет: 2 г в сутки (0,5 г каждые 6 часов или 1 г каждые 12 часов);
2. дети от 1 месяца до 12 лет: 10 мг/кг каждые 6 часов, суточная доза 40 мг/кг;
3. новорождённые: начальная доза 15 мг/кг, затем 10 мг/кг каждые 12 часов на 1-й неделе жизни, со 2-й недели — каждые 8 часов до возраста 1 месяца.

Показания к антибиотикотерапии в послеоперационном периоде

1. загрязнение раны инородными телами;
2. пластика вдавленного перелома протезом;
3. нагноившиеся раны головы.

При нагноении раны

1. снятие швов, ревизия раны, вторичная хирургическая обработка;
2. удаление титановых или иных пластических материалов;
3. вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) челюстно-лицевой области внеротовым доступом или абсцесса полости рта;
4. посев гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы;
5. продолжение этиотропной терапии, местное лечение.

4.7 Обезболивание и иное лечение

Остеосинтез выполняется под общим обезболиванием с интубацией через нос или рот, ортопедические манипуляции — под премедикацией и местной анестезией.

При нарушении всех компонентов приёма пищи питание осуществляют через зонд, при неэффективности — парентерально. Детям **до 3 лет** назначают молочную диету, старше — челюстную. Физиотерапию назначает физиотерапевт.

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Экстренная госпитализация в отделение челюстно-лицевой хирургии

1. подозрение на перелом челюсти любой локализации или его наличие;
2. раны мягких тканей лица и полости рта;
3. обширные раны мягких тканей челюстно-лицевой области.

Пострадавших с множественными переломами госпитализируют в многопрофильный стационар с нейрохирургией и нейрореанимацией, круглосуточной КТ; при транспортировке — временная иммобилизация челюстей. Плановой госпитализации нет.

Показания к выписке

1. выполнены запланированные исследования;
2. восстановлена анатомическая целостность челюстно-лицевой области;
3. нет признаков послеоперационных осложнений.

5.2 Медицинская реабилитация

Всем пациентам с множественными переломами черепа и сочетанной ЧМТ после иммобилизации костных фрагментов показаны реабилитационные мероприятия для полного физического и социального восстановления.

5.3 Диспансерное наблюдение

Детям диспансеризация проводится на весь период до завершения роста лицевых костей. Осмотры назначают **через 2–4 недели**, 3, 6 месяцев и год.

Участники наблюдения

1. челюстно-лицевой хирург;
2. невролог и офтальмолог;
3. оториноларинголог;
4. ортодонт и детский стоматолог.

После выписки пациента наблюдает невролог **1 раз в 3 месяца** в первый год, затем **1 раз в 6 месяцев**, поскольку возможны посттравматическая эпилепсия, гидроцефалия, ликворея.

Обследование на 1-м году диспансерного наблюдения

1. КТ головного мозга;
2. электроэнцефалография;
3. консультация невролога;
4. консультация офтальмолога.

Через **4 недели** после операции проводят контрольное рентгенологическое исследование для оценки консолидации фрагментов и исключения посттравматического воспаления в верхнечелюстной пазухе.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Множественные переломы мозгового и лицевого отделов черепа»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 24.12.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2027 года

Код в рубрикаторе	871_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России; Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- В разделе 7 при делении на группы перелом верхней челюсти по Ле Фор I и II отнесён к тяжёлым переломам лица (1-я группа), а Ле Фор III (черепно-лицевое разъединение) — к нетяжёлым (2-я группа); от группы зависят сроки иммобилизации.